

MEDICAL NARRATIVE HARMONIZATION

DISCREPANCY ANALYSIS & CLAIM GUARANTEE ASSESSMENT

Date: 10 October 2026

Compliance: HIPAA & PDPA Standard

SECTION 1: EXECUTIVE DISCREPANCY SUMMARY

จุดที่พบความขัดแย้ง (Discrepancy Identified): ระยะเวลาเริ่มต้นของอาการปวดท้อง (Onset / History of Present Illness Timeline)

Source	Clinical Narrative & Timeline Details
ER Physician Note 10/10/2026 08:00	ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องรุนแรงเฉียบพลันบริเวณท้องน้อยด้านขวา เป็นมา 6 ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล (Severe acute RLQ pain for 6 hours).
Surgical Specialist Note 10/10/2026 10:30	ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดตื้อๆ เป็นๆ หายๆ บริเวณท้องน้อยด้านขวาตั้งแต่ 3 วันก่อน ก่อนจะมีอาการปวดรุนแรงขึ้นในวันนี้ (Onset 3 days ago, intermittent dull pain, worse today).

Action Item สำหรับผู้จัดการ (Managerial Action Item): ประสานงานแพทย์เจ้าของไข้หรือศัลยแพทย์ผู้ดูแลเพื่อออกหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม (Clarification Letter / Addendum) ยืนยัน Timeline ที่แน่นอน เนื่องจากความแตกต่างของระยะเวลา 3 วัน เทียบกับ 6 ชั่วโมง อาจส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาเงื่อนไขโรคที่เป็นมาก่อนการประกันภัย (Pre-existing Condition) หรือระยะเวลารอดคอย (Waiting Period) ของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ

SECTION 2: HARMONIZED DRAFT MEDICAL REPORT

Patient Name/ID:	Patient (Anonymized)	Admission Date:	10 October 2026
Age / Gender:	ไม่พบข้อมูล [อายุ/เพศ]	Document Ref:	INT-CLAIM-20261010

Chief Complaint & History of Present Illness (HPI):

Chief Complaint: Acute right lower quadrant (RLQ) abdominal pain.

HPI: Patient presented to the Emergency Room on 10 October 2026 at 08:00 with severe right lower quadrant abdominal pain accompanied by fever (BT 38.2 °C). Note: ER Note documents an acute 6-hour duration prior to arrival, whereas Surgical Specialist Note indicates intermittent dull pain commencing 3 days prior, with acute intensity escalation on the day of presentation.

Clinical Findings & Investigations:

- Physical Examination: Abdomen reveals marked tenderness with positive rebound tenderness at RLQ.
- Vital Signs: Body Temperature 38.2 °C (Fever).
- Laboratory Investigations: Complete Blood Count (CBC) demonstrates Leukocytosis with WBC count of 15,000 /mCL.
- Imaging Investigations: Abdominal Ultrasound performed on 10 October 2026 demonstrates a non-compressible appendix measuring 8 mm in diameter, indicative of acute appendiceal inflammation.

Final Diagnosis & Medical Necessity Assessment:

- Final Diagnosis: Acute suppurative appendicitis (ICD-10: K35.8 - Other and unspecified acute appendicitis).
- Medical Necessity Assessment: Urgent surgical intervention is medically necessary due to active suppurative appendicitis confirmed via clinical examination, leukocytosis, and ultrasonography. Immediate surgery is required to prevent acute perforation, peritonitis, and severe septic complications.

Treatment Plan & Estimated Length of Stay (LOS):

Treatment Plan: Operative management via Appendectomy.